

# LES OS DE LA FACE

## I-INTRODUCTION

La face osseuse est la partie antéro-inférieure de l'extrémité céphalique. Elle limite avec le crâne des cavités occupées par les organes de sens. Elle est constituée par des os plats et irréguliers, pneumatiques creusés de cavités aériques (sinus).

Le squelette de la face entoure également les segments initiaux des organes digestifs et respiratoires. La face osseuse est formée de treize os fixes soudés entre eux et au crâne et un os mobile.

Les os fixes comprennent :

- six os pairs : le maxillaire, l'os zygomatique, l'os lacrymal, le cornet nasal inférieur, l'os nasal et l'os palatin,
- Un os impair : le vomer

L'os mobile : c'est la mandibule

## II-ANATOMIE DESCRIPTIVE DES OS DE LA FACE :

### A-LA MANDIBULE :

- Os impair et médian.
- Le seul os mobile du massif cranio facial.
- Il a la forme d'un fer à cheval concave et ouvert en arrière.

Présente à décrire :

- ✓ Partie central, corps de la mandibule.
- ✓ Deux branches qui sont presque coudés à angle droit par rapport au corps.

#### a- Le corps :

Il est horizontal, arqué, à concavité postérieure, avec deux faces, une partie alvéolaire et une base.

**1-La face externe :** elle est marquée sur la ligne médiane, par la symphyse mentonnière et latéralement, par la ligne oblique. Le foramen mentonnier, situé en dessous de la 2ème prémolaire, livre passage aux vaisseaux et nerfs mentonniers.

**2-La face interne :** Elle est concave en arrière et présente :

- *Les épines mentonnières :* deux paires situées de chaque côté de la ligne médiane sur les épines supérieures s'insèrent les muscles génio-glosses, et sur les épines inférieures, les muscles génio-hyoïdiens.
- *La fossette digastrique :* donne insertion au muscle digastrique.
- *La ligne myélo-hyoïdienne :* Elle donne insertion dans sa partie antérieure au muscle mylo-hyoïdien, dans sa partie postérieure, au muscle constricteur supérieur du pharynx.
- *La fosse sublinguale :* Située au-dessus de la ligne myélo-hyoïdienne, elle contient la glande sublinguale.
- *La fosse submandibulaire :* située au-dessous de cette ligne, elle contient la glande submandibulaire

**3- Le bord alvéolaire (supérieur) :** Il est creusé de 16 cavités alvéolaires pour l'implantation des dents.

**4- Le bord inférieur ou base :** Libre moussu sous cutané, qui donne insertion au muscle platysma.

#### b- Branches de la mandibule :

Rectangulaire, à grand axe vertical, chaque branche présente deux faces et quatre bords.

**1- La face externe :** Sa partie inférieure, ou tubérosité massétérique, donne insertion au muscle masséter.

**2- La face interne :** elle présente :

- ✓ *Le foramen mandibulaire :* Situé au milieu de cette face, livre passage aux vaisseaux et nerfs alvéolaires inférieurs. Cet orifice est surplombé en avant par une crête ou épine, la lingula mandibulaire ou épine de Spix.

- ✓ *La tubérosité ptérygoïdienne* : Située dans sa partie inférieure et donne insertion au muscle ptérygoïdien médial.

**3- Le bord supérieur** : Il présente deux processus et une incisure,

- ✓ le processus coronoïde, en avant. Il donne insertion au muscle temporal.
- ✓ Le processus condyloïde, en arrière. Il s'articule avec l'os temporal, formant l'articulation temporo-mandibulaire.
- ✓ l'incisure mandibulaire : Concave vers le haut et sépare les deux processus

**4- Le bord postérieur** : Il est épais, arrondi, et en rapport avec la glande parotide.

**5- Le bord antérieur** : Il est tranchant et en continuité avec la ligne oblique.

## **B- LE MAXILLAIRE :**

- Le maxillaire, os pair, s'articule avec tous les os de la face et également avec les os crâniens, frontal, ethmoïde, et sphénoïde. En s'articulant avec son homologue, il forme l'arcade dentaire supérieure.
- C'est un os pneumatisé creusé d'une cavité sinusienne importante.
- Il est formé d'un corps d'où se détachent quatre processus, zygomatique, frontal, alvéolaire et palatin

### **a- Le corps :**

De forme pyramidale triangulaire. Présente quatre faces : jugale, infra-temporale, orbitaire et nasale.

**1- La face jugale** : elle est antérieure, sous-cutanée et palpable. Elle est marquée, en bas, par la saillie verticale du jugum de la canine, qui sépare les fosses incisive et canine.

**2- La face infra-temporale** : constitue la paroi antérieure de la fosse infra-temporale et de la fissure ptérygo-maxillaire.

**3- La face orbitaire** : elle forme une grande partie du plancher de l'orbite

**4- La face nasale** : elle est médiale et forme une partie de la paroi latérale de la cavité nasale. Elle présente au centre le hiatus du sinus maxillaire,

### **b- Les processus :**

**1- Le processus zygomatique** : S'étend latéralement pour s'unir avec le processus maxillaire de l'os zygomatique.

**2- Le processus frontal** : Se dirige vers le haut pour s'unir avec l'os nasal, le frontal, l'ethmoïde et le lacrymal.

**3- Le processus palatin** : processus horizontal et médial. Il s'unit à son opposé et sépare les cavités nasale et buccale.

**4- Le processus alvéolaire** : processus arciforme, il présente sur sa face externe des saillies verticales, les jugums alvéolaires. Son bord inférieur, ou arcade alvéolaire, est creusé d'alvéoles dentaires.

## **C-L'OS PALATIN :**

Os pair, qui a la forme d'un L avec :

- *Une lame perpendiculaire* : vertical, rectangulaire participant à la constitution de la fosse ptérygo-palatine et à la paroi latérale des fosses nasales.

- ✓ *Un petit processus orbitaire* qui contribue à former l'orbite
- ✓ Elle présente sur son bord supérieur un orifice répondant à l'os sphénoïde et forme le foramen sphéno-palatin.

- *Une lame horizontale* : Constitue la partie postérieure du palais osseux et la limite inférieure des cavités nasales.

Un petit processus pyramidal : situé à la jonction des 2 parties perpendiculaire et horizontale.

De chaque côté le palatin s'unit à l'os sphénoïde et l'os ethmoïde, aux os maxillaires et au cornet nasal inférieur homolatéraux.

## **D- L'OS MALAIRE OU ZYGOMATIQUE :**

- Os pair, c'est l'os de la pommette. Il possède 3 processus.

- ✓ Les processus frontal et maxillaire participent à la construction de l'orbite
- ✓ Le processus temporal participe à la formation de l'arcade zygomatique

- De chaque côté, il s'unit avec l'os frontal, et les os temporal et maxillaire homolatéraux.

## **E- L'OS LACRYMAL OU UNGUIS :**

- Os pair, rectangulaire, mince.

- Il constitue un élément de la paroi médiale de l'orbite ainsi que la paroi latérale des cavités nasales.

- La région en rapport avec le processus frontal de l'os maxillaire représente la fosse lacrymale contenant le sac lacrymal.

- Il s'articule :

- ✓ En avant : avec le processus frontal de l'os maxillaire
- ✓ En haut : avec le processus orbitaire de l'os frontal
- ✓ En arrière : avec l'ethmoïde
- ✓ En bas : avec le maxillaire et le cornet nasal

### ***F- L'OS NASAL :***

L'os nasal est un os pair, quadrilatère s'adossant à son homologue pour constituer le squelette du dos du nez. Il s'articule :

- ✓ En haut : avec le bord nasal du frontal
- ✓ En bas : il se continue avec le cartilage nasal
- ✓ En médial : avec son opposé
- ✓ En latéral : avec la partie haute du processus frontal du maxillaire

### ***G- LE CORNET INFÉRIEUR :***

- Os pair.

- C'est une lame osseuse recourbée appartenant à la paroi latérale des fosses nasales.

- De chaque côté il s'unit avec les os maxillaires, palatin, et lacrymal homolatéraux. Ainsi qu'à l'os ethmoïde.

### ***H- LE VOMER :***

- Os impair, c'est une lame quadrilatère. Il constitue la partie postéro-inférieure du septum nasal.

- Os situé dans le plan médian, qui s'unit aux os sphénoïde et ethmoïde dans leurs portions médianes ainsi que sur la ligne médiane de la face supérieure du palais osseux, point de rencontre des deux os maxillaires et palatins.

- Son bord postérieur est libre, ne s'unissant avec aucun autre os.

## ***V. APPLICATIONS CLINIQUES***

**Devant tous signes** : enfoncement de la pommette, marche d'escaliers, hypoesthésie du nerf V2, épistaxis.

- Il faut suspecter une fracture zygomatiko-faciale
- Faire un examen ophtalmologique soigneux (médiolégale)
- Traiter en urgence en cas de signes fonctionnels

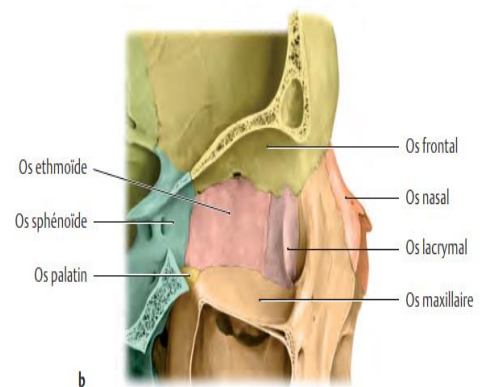
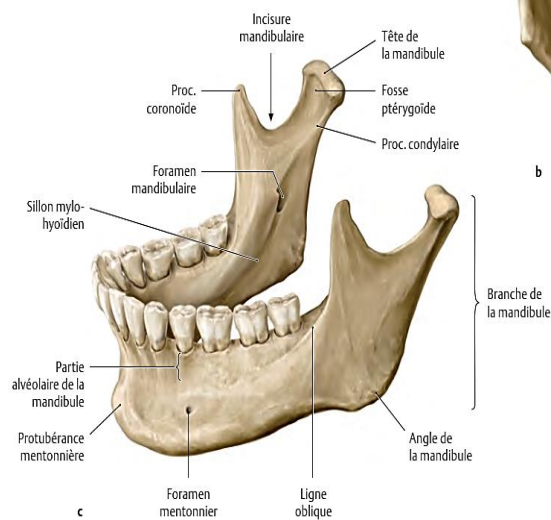
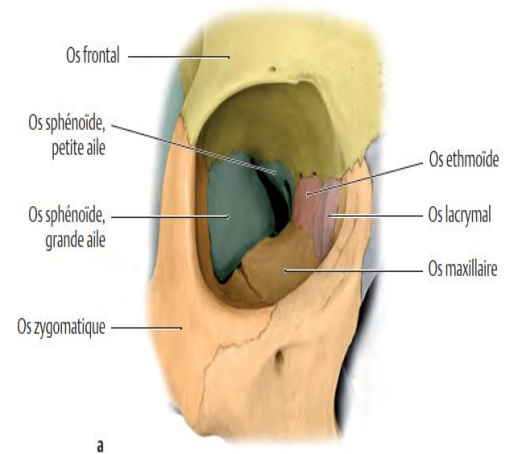
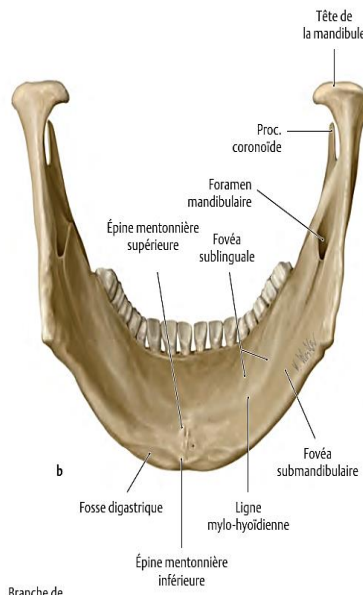
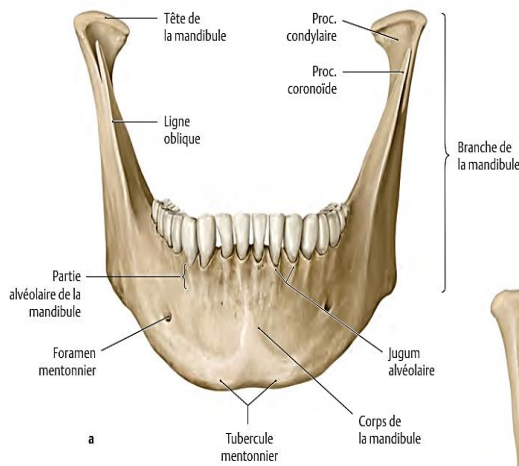
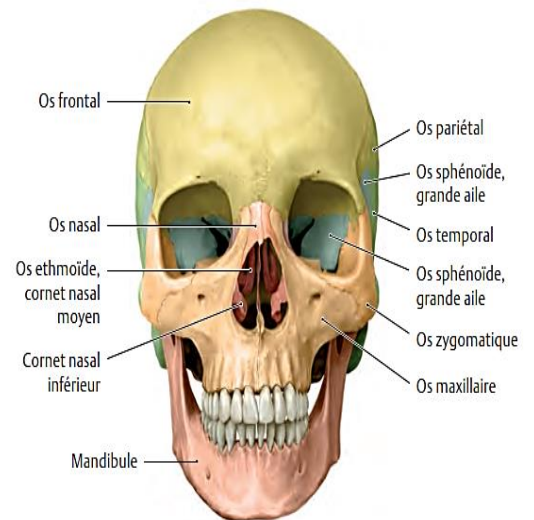
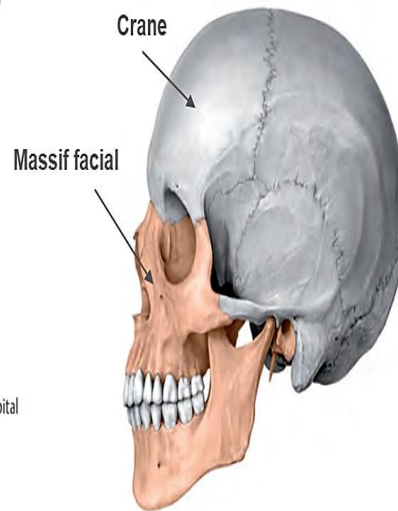
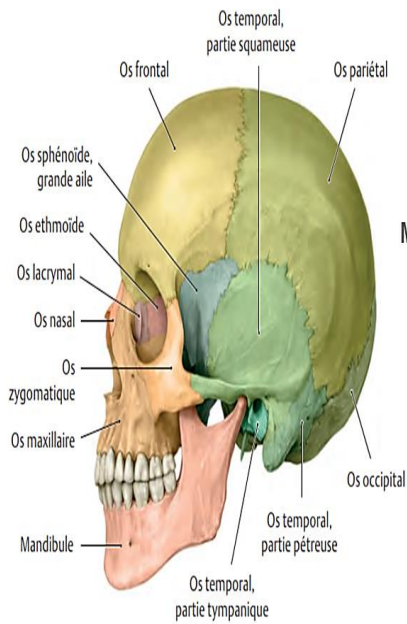
**Devant** : des troubles de l'occlusion, mobilité de l'arcade dentaire supérieure isolée (Le Fort I) ou en association avec le nez (Le Fort II) et/ou les zygomatiques (Le Fort III)

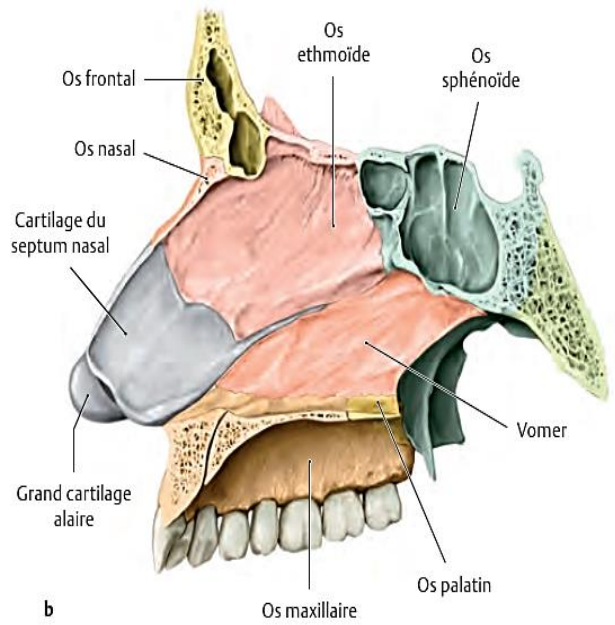
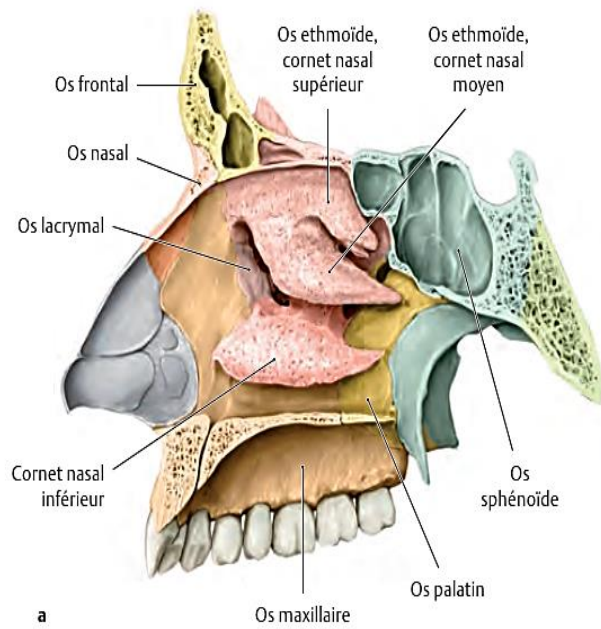
- Atteintes sensorielles possibles (Le Fort II et III)
- Il faut suspecter les fractures occluso-faciales de Le Fort
- Imagerie : scanner
- Complications : ophtalmologiques, neuroméningées, hémorragiques, morphologiques.

## ***III. CONCLUSION***

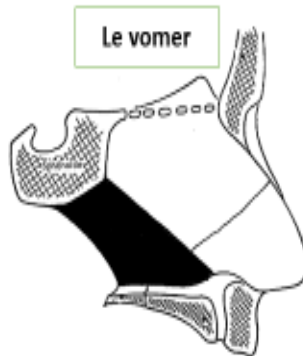
Situé à la partie antérieure et inférieure de la tête osseuse, le squelette de la face se divise en deux parties par rapport à la cavité buccale :

- Inférieure : massif facial inférieur : Mandibule.
- Supérieure : massif facial supérieur, composé de treize os, un seul est impair :
  - Le vomer.
  - Les autres sont pairs et symétriques : maxillaire, os zygomatique, os nasal, os lacrymal, le palatin et le cornet inférieur.





### Massif facial supérieur



### Massif facial inférieur

